Денова Л. Д.
асистент кафедри терапії

Аніщенко В. М.
клінічний ординатор
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна

НОВЕ В ПРОФІЛАКТИЦІ, ЛІКУВАННІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

Цукровий діабет (ЦД) – це група метаболічних захворювань, що характеризується гіперглікемією, яка є наслідком дефектів секреції інсуліну, дії інсуліну або обох цих чинників.[8]

В останні роки захворюваність на цукровий діабет у світі виходить на третє місце, після серцево-судинних та онкологічних захворювань. За оцінками експертів ВООЗ до 2025 року кількість хворих на цукровий діабет становитиме 525 млн осіб.[1, 2]

В Україні на кінець 2012 року було зареєстровано 1 311 335 хворих на діабет, з них 95% - хворі на цукровий діабет 2 типу (ЦД 2). У багатьох хворих на момент встановлення діагнозу тривалість захворювання складає 7-12 років, а отже наявні ускладнення. У зв'язку з цим постала проблема ранньої діагностики та профілактики ЦД 2 типу та його ускладнень.[8]

Фахівці ВООЗ рекомендують проводити скрінінг серед груп ризику ЦД 2 типу. Для цього необхідно виявлення наявності факторів ризику у населення. До факторів ризику цукрового діабету 2 типу, наявність яких свідчить про необхідність обстеження на ЦД 2 типу відносяться:

1. Сімейний анамнез цукрового діабету.
2. ССЗ.
3. Надмірна вага або ожиріння
4. Малорухливий спосіб життя.
5. Раніше визначені порушення толерантності до глюкози, порушення глікемії натщесерце і / або метаболічний синдром.
6. АГ.
7. Підвищений рівень тригліцеридів, низький рівень концентрації холестерину ліпопротеїнів високої щільності, або обох показників.
8. Гестаційний ЦД в анамнезі.
9. Народження дитини вагою більше 4 кг.
10. Синдром полікістозних яєчників.
11. Антипсихотична терапія при лікуванні шизофренії та / або важкі біполярні захворювання.[3]

Головним завданням терапії ЦД 2 типу є зниження сумарного ризику ускладнень. Здійснення цього завдання полягає у досягненні та підтримці цільового рівня глікемії, артеріального тиску, ліпідного профілю та застосу-

вання антитромбоцитарної терапії. Контроль рівня глюкози в крові, АТ, ліпідного профілю зменшує прогресування розвитку ураження органів зору, нирок, периферичних нервів,серцево-судинної системи. Антитромбоцитарна терапія у пацієнтів з ЦД 2 типу знижує ризик ССЗ.[7, 8]

Дуже важливе значення в досягненні та утриманні цільового рівня показників займає модифікація способу життя: зниження маси тіла, дотримання дієти розробленої лікарем дієтологом, діета повинна бути зі зниженим вмістом вуглеводів, включення в раціон харчових волокон, дозовані фізичні навантаження. Хворим на ЦД 2 типу без ускладнень рекомендовані навіть силові вправи. Одним з найважливіших пунктів є відмова від шкідливих звичок: повна відмова від паління та зменшення вживання алкоголю.[7, 8]

Для корекції рівня глікемії в даний час існуть такі групи цукрознижувальних препаратів: метформін, похідні сульфонсечовини, інгібітори альфаглюкозидази, тіазолідиндіони, інгібітори дипептидилпептидази 4, агоністи рецепторів глюкагонподібного пептиду-1 та інсулін. Нещодаво на світовому фарцевтичному ринку також зявилась нова група препаратів – селективні і зворотні інгібітори натрійглюкозокотранспортера-2. Також створені комбіновані пероральні цукрознижувальні препарати. [5]

Для контролю рівня артеріального тиску препаратами першої лінії є інгібітори АПФ. Але останнім часом надається перевага сартанам, оскільки вони знижують інсулінорезистентність тканин. Якщо наявні протипоказання до інгібіторів АПФ або сартанів можуть призначатися антагоністи кальцієвих каналів. Також вони можуть застосовуватись у комбінації з інгібіторами АПФ або сартанами при неможливості досягнення цільового рівня АТ монотерапією. Також додатковим препаратом в комбінованій терапії може використовуватись тіазидний діуретик. При неефективності терапії двома препаратами додають β або α адреноблокатори. Також можливе додавання калійзберігаючих діуретинів.[7]

Як було сказано вище одним із напрямків профілактики ускладнень ЦД 2 типу є антитромбоцитарна терапія, з цією метою застосовують ацетил саліцилову кислоту. При непереносимості ацетилсаліцилової кислоти застосовують клопідогрель.[4]

Одним із найважливіших аспектів зниження ризику ускладнень цукрового діабету є контроль ліпідного профілю. Він здійснюється за рахунок призначення статинів. При неефективності максимальних доз статинів додатково призначають езетиміб. При підвищенні рівня тригліцеридів необхідне застосування фібратів.[6]

Головними завданнями профілактики ускладнень ЦД 2 типу є контроль цільових показників і розпізнавання та контроль хронічних ускладнень. Це можливо лише завдяки постійній співпраці лікаря і пацієнта.[8]

Список літератури:

1. Дедов И. И. « Сахарный диабет: развитие технологий в диагностике, лечении и профилактике.» Сахарный диабет 3/2010. – С. 6-13

2. Дедов И. И. «Инновационные технологии в лечении и профилактика сахарного диабета и его осложнений». Сахарный диабет 2013 (3): 4-10
3. М.Н. Мамедов, Е.А. Поддубская, М.Н. Ковригина, З.О. Угурчиева, Р.Т. Дигигова «Первичная профилактика сахарного диабета: коррекция ранних нарушений углеводного обмена в кардиологической практике» Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2012 8 (1). – С. 81-87
4. Савустьяненко А.В. «Актуальность применения ацетилсалициловой кислоты в низких дозах для профилактики сердечно-сосудистых осложнений» Артериальная гипертензия 4(24)2012 79-84
5. В.Г. Каджарян, Н.И. Капшитарь «Новое в лечении сахарного диабета 2 типа» Запророжский медицинский журнал № 1 (82) 2014 С. 74-79
6. B. H. Subedi, R. Tota-Maharai, M. G. Silverman, C.M. Minder at all «Роль статинов в лечении сахарного диабета» Diabetes Spectrum 2013 – Т 26 – № 3 С. 156-165
7. Аешек Чуприняк, Пол Валенси, Любов Соколова «Пациент с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой патологией: скрининг, профілактика, вмешательства» № 3 2013 – С. 47-52
8. Лисенко Г.І. «Цукровий діабет у загально лікарській практиці відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій « Мистецтво лікування 2011 № 4. – С. 42-45. № 5/6 – С. 40-43

Лизогуб В. Г.
доктор медичних наук,
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4
Артемчук О. О.
кандидат медичних наук,
асистент кафедри внутрішньої медицини № 4
Мошковська Ю. О.
кандидат медичних наук,
доцент кафедри внутрішньої медицини № 4
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ТРИГЛІЦЕРИДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ СТАТИНАМИ

Мета дослідження. На основі вивчення у хворих на нестабільну (прогресуючу(ПрС)) стенокардію змін жирнокислотного спектра (ЖКС) тригліцери-